

一、疾病理解與病理機轉

您的身體可能同時面臨多種健康挑戰。糖尿病會讓血糖控制變得不穩定,長期高血糖可能損傷神經和血管,導致足部感覺變差、傷口不易癒合。腎臟功能衰退時,無法有效排除體內多餘的鉀和磷,這些物質累積會影響心臟跳動和骨骼健康。心臟節律不整表示心跳的節奏和速度出現異常,可能太快、太慢或不規則。高血壓則是血管長期承受過大壓力,會默默傷害心臟、腦部和腎臟。這些問題常常相互影響,需要整體性的照顧和管理。

二、藥物知識與服藥遵從

1. 按時服用醫師開立的降血糖藥物或胰島素,幫助維持血糖穩定。
2. 若有使用磷結合劑,請咬碎後和食物一起食用,每吃一兩口食物就配上一小塊。
3. 抗心律不整藥物必須由心臟科醫師處方,切勿自行調整劑量或停藥。
4. 高血壓藥物需要規律服用,即使感覺良好也不可隨意停藥。
5. 不亂服用止痛劑或來路不明的藥物,特別是腎功能不佳者更需注意。
6. 所有藥物都應按照醫囑時間和劑量服用,如有疑問請先諮詢醫療人員。

三、警訊辨識與處置行為

1. 出現呼吸急促、喘不過氣、嘴唇發紫時,應立即就醫。
2. 意識狀態改變如混亂、昏沉或叫不醒時,需要緊急醫療協助。
3. 持續胸悶、心悸或心跳異常時,應盡快返院檢查。
4. 嘔吐咖啡色或血色液體、解血便或黑便時,表示可能有出血狀況。
5. 血糖過高或過低出現不適症狀時,應立即監測血糖並採取適當措施。
6. 傷口出現紅、腫、熱、痛或有膿狀分泌物時,需立即處理並就醫。
7. 體溫持續超過38.5°C或低於36°C時,應尋求醫療協助。

四、飲食與活動建議

1. 糖尿病飲食需控制醣類攝取,三餐飯前血糖控制在80-130 mg/dL,飯後兩小時控制在160mg/dL以下。
2. 腎功能不佳者需採低鉀飲食,每日鉀攝取限制在2~3公克,避免高鉀食物如香蕉、番茄、堅果等。
3. 低磷飲食避免食用加工食品如香腸、火腿、起司、汽水、優酪乳等含磷量高的食物。
4. 高血壓患者需限鹽飲食,每日鹽分限制在2~4公克,採用DASH飲食多蔬果、低脂、全穀。
5. 選擇新鮮食材,避免罐頭、醃漬品和濃湯汁,蔬菜建議先用水煮3~5分鐘再烹調。
6. 適度運動每週5~7天,每次至少30分鐘有氧運動,但需避免過度勞累。
7. 足部護理每天檢查皮膚狀況,選擇合適鞋襪,避免赤腳行走以防受傷。

五、出院追蹤與門診照護導引

1. 定期回診追蹤血糖、血壓、肝腎功能及電解質狀況,通常每1~3個月一次。
2. 血糖控制不良期間每天監測4次(三餐前及睡前),控制良好時每週1~2次不同時段監測。
3. 攜帶血糖記錄本回診,註明日期、時間、餐前餐後數值及特殊情況供醫師參考。

4. 定期進行足部檢查,特別是糖尿病患者應每3~6個月接受專業足部評估。
5. 按照醫囑定期接受心電圖、心臟超音波等檢查,追蹤心律狀況。
6. 腎功能追蹤需定期檢驗血液尿素氮、血清肌酸酐及24小時尿液收集計算腎絲球過濾率。
7. 如有任何不適症狀或疑問,可撥打諮詢電話(02)2737-2181聯繫相關科室護理人員。

六、慢性疾病追蹤與照護提醒

【個人化慢性疾病追蹤與照護提醒】

以下慢性病是依診斷 ICD-10 自動辨識,請配合醫師門診追蹤與用藥調整。

■ 肝硬化(ICD-10: K7469)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 絕對戒酒;採低鹽飲食(< 2 公克/天),減少腹水發生。
- 定期服用 Lactulose(若有肝性腦病變風險),確保每日 2~3 次軟便。
- 出現腹部急速脹大、意識混亂、嘔血或解黑便時,需緊急就醫。

■ 慢性腎臟病(ICD-10: N183)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 採低磷、低鉀飲食(視腎功能分期調整),蔬菜煮熟後倒掉湯汁可降低鉀含量。
- 嚴格限制液體及鹽分攝取,避免使用止痛藥(NSAIDs)或來路不明的中草藥。
- 定期回診追蹤腎功能(尿素氮、肌酸酐、電解質),準時接受透析治療(若需要)。

■ 心律不整(ICD-10: I4892)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 避免菸、酒、濃茶、咖啡等刺激性物質,這些可能誘發心律不整。
- 出現持續心悸、胸悶、頭暈、昏厥時,應立即就醫並記錄發作時間與症狀。
- 抗心律不整藥物不可自行調整劑量或停藥,定期回心臟科門診追蹤心電圖。

■ 高血壓(ICD-10: I129)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日早晚各量一次血壓,遵循 722 原則(7天、每日早晚各1次、每次量2遍),記錄後回診時提供醫師參考。
- 每日鹽分攝取限制在 2~4 公克,採用 DASH 飲食(多蔬果、全穀、低脂)。
- 規律服用降壓藥,不可自行停藥或減量;戒菸、限酒、維持 BMI 20~25。

■ 冠狀動脈疾病(ICD-10: I25118)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。

- 目前用藥中可能包含降血脂藥物,請按時服用;若有明顯肌肉痠痛或茶色尿,請告知醫療人員。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 隨身攜帶舌下硝酸甘油,胸痛發作時立即含服;若5分鐘未緩解可再含一片,仍無效需緊急就醫。
- 按時服用抗血小板藥物(如阿斯匹靈、Clopidogrel),不可自行停藥。
- 控制高血壓、高血脂、糖尿病等危險因子;採低鹽低脂飲食,每週規律有氧運動3次以上。

■ 第二型糖尿病(ICD-10: E119)

- 目前用藥中可能包含降血糖藥或胰島素,請規律監測血糖,並留意冒冷汗、手抖、心悸等低血糖症狀。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 依醫師指示定時測量血糖,餐前目標 80~130 mg/dL,餐後2小時目標 < 160 mg/dL。
- 詳細記錄每次血糖值(日期、時間、餐前/後、藥物劑量),回診時提供醫師調整劑量。
- 每日檢查雙腳皮膚,選擇棉質吸汗襪與寬頭透氣鞋,避免赤腳或穿夾腳拖。

七、重要注意事項

【注意事項】以下衛教內容之間存在需要醫師協助判斷的情況:

1. 末期腎臟疾病 與 惡病質病人飲食方面常見的問題

說明:腎臟病需限蛋白質、限鉀磷,但惡病質需高蛋白高熱量飲食

請與您的醫師或護理師確認:請與腎臟科醫師及營養師共同制定個別化飲食計畫,兩者需要平衡

2. 準備低鉀飲食 與 惡病質病人飲食方面常見的問題

說明:低鉀飲食需限制蔬果、豆類,但惡病質需多樣化高營養飲食

請與您的醫師或護理師確認:請與腎臟科及營養師討論,在低鉀限制內選擇高熱量食物

八、參考衛教手冊

1. 血糖自我監測衛教指導
2. 準備低鉀飲食
3. 急性呼吸衰竭
4. 肝硬化
5. 惡病質病人飲食方面常見的問題
6. 低磷飲食
7. 周邊置入中心靜脈導管居家照護需知
8. 敗血症
9. 末期腎臟疾病
10. 心臟節律不整
11. 高血壓

12. 糖尿病足部病變護理指導

※ 此衛教手冊由人工智慧輔助生成，僅供參考，不代替醫師專業建議。

生成日期：2026-05-31